

I...i zamiast albo...albo

Ambiwalencja w AN nie jest „słabością motywacji” — jest strukturalną cechą zaburzenia. Pacjent jednocześnie chce i nie chce zdrowieć. Obie prawdy współistnieją.

CZAS: 20–30 min sesji + powracanie **REALIZACJA:** wczesna terapia, przy oporze, przy stagnacji

ŹRÓDŁO: Vitousek, Watson & Wilson (1998); Miller & Rollnick (2012, *Motivational Interviewing*, 3rd ed., Guilford); Treasure & Schmidt (2013, MANTRA)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **czym jest ambiwalencja** w AN i dlaczego perswazja ją wzmacnia. W sekcji 02 — **siedem zasad pracy z ambiwalencją**. Sekcja 03 — **moja praca**: rozpoznanie własnej ambiwalencji bez oceny. Sekcja 04 — czego oczekiwać w czasie.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Ambiwalencja w AN *nie* jest „słabością motywacji” — jest strukturalną cechą zaburzenia. Pacjent *jednocześnie* chce wyzdrowieć (cierpi, widzi koszty) i nie chce wyzdrowieć (boi się utraty kontroli, tożsamości). Vitousek, Watson & Wilson (1998): obie prawdy *współistnieją w tej samej chwili*. Próba „przekonania” wzmacnia opór (*reactance*, Brehm, 1966). Skuteczne: MI Miller & Rollnick (2013) — wywoływanie argumentów od pacjenta, nie ich narzucanie.

01



Czym jest ambiwalencja w AN — i dlaczego perswazja ją wzmacnia

AMBIWALENCJA — STRUKTURALNA CECZA

Pacjent *jednocześnie*: **chce** wyzdrowieć (cierpi, widzi skutki) i **nie chce** (boi się utraty kontroli, tożsamości). Obie prawdy współistnieją — w *tej samej chwili*, nie sekwencyjnie.

REAKTANCJA — PARADOKS PERSWAZJI

Im bardziej terapeuta lub bliski **naciska** na zmianę, tym silniej pacjent broni AN (Miller & Rollnick, 2012). „*Righting reflex*” terapeuty wzmacnia opór. Walidacja działa, perswazja nie.

ZASADA	REALIZACJA
1 · Walidacja	„Ambiwalencja jest normalna w AN — nie jest twoją słabością”. Pacjent słyszy, że jego doświadczenie jest rozumiane.
2 · Nie wybieraj strony	Terapeuta <i>nie</i> staje po stronie „głosu zdrowienia” przeciw „głosowi AN”. To wzmacnia konflikt wewnętrzny.
3 · Eksploracja funkcji	Co AN daje pacjentowi? Kontrola, tożsamość, bezpieczeństwo, sukces, regulacja emocji. Bez tej eksploracji praca z motywacją nie działa.
4 · Odkrywanie sprzeczności	Miedzy wartościami pacjenta (rodzina, sztuka, pasje) a tym, co AN mu zabiera. <i>Pacjent</i> widzi sprzeczność — nie terapeuta mu ją wskazuje.
5 · Wywołuj „change talk”	Pacjent <i>sam</i> artykułuje argumenty za zmianą. Terapeuta wybiera momenty, w których to wypowiedzenie jest możliwe, i je wzmacnia odbiciami.
6 · „I...i” zamiast „albo...albo”	Można <i>jednocześnie</i> cenić AN i widzieć jej koszty. <i>Jednocześnie</i> bać się zmiany i jej pragnąć. Obie prawdy współistnieją.
7 · Cierpliwość	Ambiwalencja przechodzi w motywację <i>przez miesiące</i> , nie tygodnie. Naturalna oscylacja — powraca w trudnych momentach. Nie jest regresem.

CZĘŚĆ MNIE, KTÓRA *CHCE* WYZDROWIEĆ

— co mi mówi, kiedy się odzywa, co widzi

CZĘŚĆ MNIE, KTÓRA *NIE CHCE* WYZDROWIEĆ

— co mi mówi, czego się boi, co chroni

KIEDY JEDEN GŁOS JEST SILNIEJSZY

— jakie sytuacje, jakie emocje wzmacniają każdy z głosów

JAK CZUJĘ SIĘ, GDY KTOŚ MNIE „PRZEKONUJE”

— co to wywołuje: opór, gniew, wycofanie; jak chciałbym/-łabym być wysłuchany/-a zamiast przekonywany/-a

Klucz: ambiwalencja w AN *nie* jest brakiem motywacji ani słabością — jest *strukturalną cechą* zaburzenia ego-syntonicznego. Pacjent *jednocześnie* chce i nie chce wyzdrowieć — obie prawdy są prawdziwe. Próby „przekonania” wzmacniają opór (mechanizm reaktancji, Miller & Rollnick, 2012). Praca polega na *walidacji* obu głosów, *eksploracji funkcji* AN, *wywoływaniu change talk*, zastąpieniu „albo...albo” przez „i...i”. Klinicysta *nie* staje po stronie „głosu zdrowienia” — to wzmacnia konflikt wewnętrzny. Cierpliwość: ambiwalencja przechodzi w motywację *przez miesiące*, nie tygodnie. Naturalna oscylacja powraca w trudnych momentach (przybieranie wagi, utrata kontroli, lęk przed pełnym powrotem) — to *nie* jest regres. **Dla bliskich:** ten sam mechanizm reaktancji działa wobec rodziny — nacisk, kontrola, perswazja *wzmacniają* AN. Najtrudniejsze i najsukcesowniejsze: walidacja połączona z *jasnym* kierunkiem leczenia, bez utraty empatii.

△ Praca z ambiwalencją jest jedną z najtrudniejszych umiejętności klinicznych. Wymaga superwizji, treningu MI lub MANTRA, refleksji nad własną tendencją do „righting reflex”. Klinicysta, który po sesji czuje frustrację „dlaczego on nie chce się zmienić?”, często sam wpadł w pułapkę perswazji — superwizja pomaga to rozpoznać i wrócić do walidującej obecności.